

Łokieć tenisisty – przyczyny, objawy, metody leczenia

AUTORZY PROJEKTU:

KATARZYNA DYŚ 72533

ERNEST KURDZIEL 72714

MATEUSZ KRASOŃ 72329

OPIS PROBLEMU FUNKCJONALNEGO

Łokieć tenisisty (łac. *epicondylitis lateralis humeri*) to w rzeczywistości nie stan zapalny, lecz **entezopatia** – choroba zwyrodnieniowo-przeciążeniowa przyczepu bliższego ścięgien mięśni prostowników nadgarstka i palców. Proces patologiczny dotyczy głównie mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka (ECRB). Dochodzi w nim do mikrourazów, dezorganizacji włókien kolagenowych oraz neowaskularyzacji, co skutkuje zaburzeniem funkcji chwytnej ręki.

PRZYCZYNY I OBJAWY KLINICZNE

Etiologia (Przyczyny):

- Powtarzalne ruchy prostowania nadgarstka i supinacji przedramienia.
- Długotrwała praca biurowa (pisanie na klawiaturze, operowanie myszką).
- Aktywność sportowa (tenis, squash) o błędnej biomechanice.
- Prace manualne (stolarze, mechanicy, stomatolodzy).

Obraz kliniczny (Objawy):

- Ostry, kłujący ból w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej.
- Promieniowanie bólu wzdłuż grzbietowej strony przedramienia.
- Spadek siły uścisku dłoni (np. ból przy witaniu się, odkręcaniu stoika).
- Dodatknie testy kliniczne (Test Thomsona, Test Cozena, Test Milla).

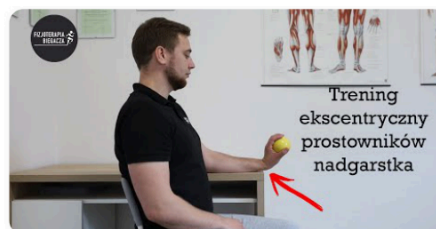
METODY LECZENIA FIZJOTERAPEUTYCZNEGO

Ze względu na degeneracyjny charakter schorzenia, terapia skupia się na stymulacji fibroblastycznej i remodelingu tkanki, a nie na leczeniu przeciwzapalnym. Złotym standardem fizjoterapii łokcia tenisisty jest połączenie kinezyterapii z celowaną terapią manualną i fizykoterapią.

1. Kinezyterapia (Trening ekscentryczny): Fundament leczenia. Polega na wolnym, kontrolowanym opuszczaniu ciężaru (rozciąganie napiętego mięśnia prostownika). Trening ten stymuluje prawidłową syntezę kolagenu typu I, poprawiając wytrzymałość mechaniczną ścięgna.

2. Terapia manualna: Zastosowanie **Głębokiego Masażu Poprzecznego (MTP)** wg Cyriaxa na przyczepie mięśnia, co zapobiega zrostom w obrębie blizny i wywołuje przekrwienie sprzyjające gojeniu. Pomocna jest także mobilizacja stawu ramienno-promieniowego.

3. Fizykoterapia i Taping: Wysoką skuteczność (udowodnioną klinicznie) wykazuje **Zewnątrzustrojowa Fala Uderzeniowa (ESWT)**. Wspomagająco stosuje się kinesiotaping odciążający oraz w fazie ostrej – krioterapię.



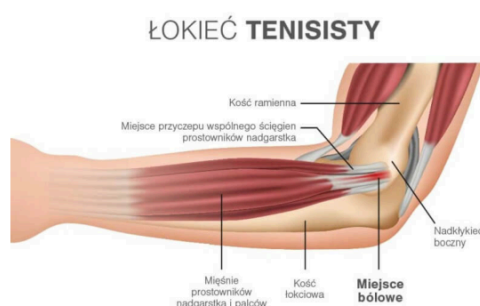
Rycina 2. Faza ekscentryczna treningu prostowników nadgarstka.

Źródło: [youtube.com/watch?v=VFq55pceMPI](https://www.youtube.com/watch?v=VFq55pceMPI) (Fizjoterapia Biegacza)



Rycina 3. Zabieg z użyciem fali uderzeniowej.

Źródło: [youtube.com/watch?v=vAxkEz7Gxk](https://www.youtube.com/watch?v=vAxkEz7Gxk)



Rycina 1. Lokalizacja zmian degeneracyjnych ścięgna m. prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka.

Źródło: rehasport.pl/lokiec/lokiec-tenisisty,5221,n,4324

LITERATURA I ŹRÓDŁA

- Bac A., Jankowicz-Szymańska A., Liszka H., Wódka K. Diagnostyka narządu ruchu w fizjoterapii. Tom 1. Edra Urban & Partner, Wrocław 2022.
- Kruczyński J. (red.). Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Wyd. III uaktualnione. PZWL, Warszawa 2023.
- Lucado A.M. i wsp. Lateral Elbow Pain and Muscle Function Impairments. J Orthop Sports Phys Ther. 2022;52(12):CPG1-CPG111. doi:10.2519/jospt.2022.0302. PMID: 36453071.
- Karbowiak M. i wsp. Management of lateral epicondylitis (tennis elbow). BMJ. 2023;381:e072574. doi:10.1136/bmj-2022-072574. PMID: 37201946.